

Falta

SONIA REGINA DONDEO ORIGO			
MEDICAMENTOS:			
SINTOMAS/QUEIXAS			
BANHEIRO			
HORA QUE ACORDA			
HORA QUE DORME	IAH = 45,4		
PRATICA EXERCICIO			
HORARIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
09/05 Adaptação do CPAP.			
22 Jua			
26/05 P = 6			
22 IAH = 3,2			
M. de uso: 10h Jua			
10/06 P = 6,6 (4 hoje)			
22 IAH = 4,7			
M. de uso: 1h 20' Jua			
27/06 ↑ a pressão P = 7,0			
22 IAH = 4,3/h			
M. de uso: 6h 40'			
Bem adaptada, hoje relatou que teve conv.			
Jua			
22/09 P = 7 cmH ₂ O			
22 IAH = 3,5/h			
M. de uso: 6h 15'			
troco o filtro Jua			
24/01 P = 7 cmH ₂ O			
22 IAH = 4,2/h			
M. de uso: 5h 5'			
Dormiu: 21hs - 2hs acord.			
Dormiu: 3hs - 4hs			
Após almoço: dormiu 1hs.			
Bem adaptada mas q insônia assa. Jua			
27/01 P = 7 cmH ₂ O			
23 IAH = 3,4/h			
M. de uso: 3h 58'			
Fuga = 10,8 l/min.			
Ordeito uso pl & T ^o do quarto. Jua			
14/04 P = 7 cmH ₂ O			
2023 IAH = 3,2/h			
M. de uso = 6h 50'			
Fuga = 5,8 l/min			
- ventagem; temer - vai fz TC c/ônio			
- inalação propomolol			

o novo filtro

nijio lavar nariz pro fino

11/07
23 P = 7 cmH₂O
IAH = 3.9 e/h
m. de uso: 5h40'
Fuga: 0.8 l/min.

Bem adapt. c/ boca gea
fua

18/10/23 P = 7 cmH₂O
IAH = 2.9 e/h
m de uso = 6 horas
fuga = 1.3 l/min.

Bem adaptada / disposta
{ ter dor lombar
melhora da tosse

31/02/24 P = 7 cmH₂O
IAH = 3.1 e/h
m uso: 4 horas
fuga = 1.2 l/min.

usou 17d / 30d. → refere mto calor
hoje filho tome pós corrid

17/09
24 P = 7 cmH₂O
IAH = 3.1 e/h
M. de uso: 5hr
Fuga = 1.5 lpm.

De 30d utilizou 22 dias.
Refere ter broncoespasmo.
Troca o filtro fua
Relata estar alivando a tosse, e q muita dor lombar

04/02
25 P = 7 cmH₂O
IAH = 3.7 e/h
M. de uso: 4hr
fuga = 1.1 lpm

Retornar daqui 21d.
Dor lombar continua.
fua

24/03
25 P = 7 cmH₂O
IAH = 2.1 e/h
M. de uso: 1h40 no mês.
Nos últimos 5 noites ↑ p/ 6hr.
Temor que colocar no radar.

Oriento sobre o uso
constante.
fua

10/06
25 P = 7 cmH₂O
IAH = 1.0 e/h
M. de uso: 4:40'
fuga = 4.4 lpm.

Relata apresentar algumas noites
de insônia.
Oriento fazer Yoga / Pilates - fua.

Bem adaptada, oriento exorc.

11/11
25 P = 7 cmH₂O
IAH = 0.8
M. de uso: 3h20

fua

Dr. Alvaro Nakano - CRM 84.287
Dr. Andréia A. Bisanha - CRM 112.331

CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO
NAKANO MEDICINA
LASER THERAPY

Indicada adaptação de
CPAP e ajuste de máscara
para Sônia R. Llonde
Lujo.

Prens de titulação: 8 cm
de H₂O.

gate.

Andréia A. Bisanha
Otorrinolaringologia
CRM 112331

CID 10: _____
Autorizo a Informação.

04/10/22

Laser Therapy

Laser Co₂ Fracionado
Rejuvenescimento
Manchas
Cicatrizes de Acne
Flacidez Cutânea
Peeling

Químico (ácidos)

BOTOX

Microagulhamento
Biorevitalização
Radiofrequência
Preenchimentos

Juvéderm

Nutricionista
Fonoaudióloga
Otorrinolaringologia

Audiometria
Impedânciometria
Emissões Otoacústicas
(teste da orelhinha)
BERA
Eletrococleografia
Vetoeletronistagmografia
Processamento Auditivo Central
Video Estroboscopia de Laringe
Video Endoscopia Nasossinusal
Video Laringoscopia com foto

CONSULTA DIA: _____

NAKANO MEDICINA SOC. EMP. LTDA ME - CNPJ 04.518.000/0001-39

CARAGUATATUBA:

Av. Dr. Arthur Costa Filho, 937 - Sala 24/25 - 2º andar
Caraguá Praia Shopping - Tel.: 12 3883.3849

www.nakanomedicina.com.br
contato@nakanomedicina.com.br

Nome: SONIA REGINA DONDEO ORIGO

Data de Nascimento: 3-9-1949

IMC: 36,45

Sexo: Feminino

Data do exame: 21-02-2022

Peso: 91 kg

Altura: 1,58 m

Médico: DR. ANTONIO CARLOS ZAMPA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 21-02-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 594,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 111,5 e 150,0 minutos. O tempo total de sono foi de 319,5, eficiência de 53,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,3%; estágio N2: 68,5%; estágio N3: 11,4%; sono REM: 17,7%. O índice de despertares foi de 22,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 45,4/hora, sendo elas 32 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 177 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e mínima de 79%, permanecendo 1,9% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 65 - 80 bpm e NREM de 63 - 85 bpm.

CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (08), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 45,4/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=79%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (7,9/hora);
9. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

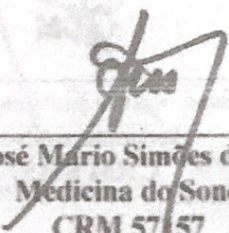
Presença de bruxismo.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Nome: SONIA REGINA DONDEO ORIGO

Data de Nascimento: 3-8-1949

IMC: 36,45

Sexo: Feminino

Data do exame: 16-03-2022

Peso: 91 kg

Altura: 1,58 m

Médico: DR. ANTONIO CARLOS ZAMPA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 16-03-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 599,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 72,5 e 150,0 minutos. O tempo total de sono foi de 278,0, eficiência de 46,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,8%; estágio N2: 48,4%; estágio N3: 31,7%; sono REM: 18,2%. O índice de despertares foi de 9,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 17,5/hora, sendo elas 4 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 77 hipopneias. A SpO2 média foi de 90% e mínima de 81%, permanecendo 17,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 63 - 78 bpm e NREM de 62 - 80 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (1), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono prolongadas;
4. número de despertares breves normal;
5. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (18,6/hora);
6. registro de ronco moderado durante o sono.

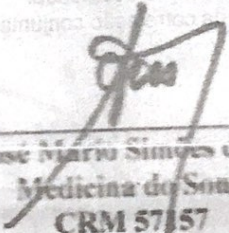
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157